



Relatório Médico: Solicitação de Exoma.

Paciente: CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA. DN: 30/06/2020.

Trata-se de lactente, atualmente com 2 ano e 5 meses de idade, com várias intercorrências desde o período neonatal tardio, quando iniciou status epilepticus: Nasceu bem, apesar das complicações da gestação. Aos 35 dias de vida começou com convulsões reentrantes no colo do pai. Foi para o HBH e diagnosticado AVC sangramento grau 3. Colocou DVE, já passou por 3 cirurgias, troca de DVE e agora tem DVP. Vem desenvolvendo muito bem cognitivo e motor fino. Atraso de marcha.

Parto normal induzido, termo, mãe teve hipotireoidismo, DMG com dieta e DHEG. PN: Mãe, 170 cm, menarca aos 14 anos. Pai, 168 cm.

PN: 2306g. Cp: 44 cm.

Ao exame: Criança apresenta vários dismorfismos, fronte proeminente, base nasal hipoplásica, micrognatia, baixa estatura significativa, cabelos esparsos.

Fez avaliação genética, que considerou a possibilidade de alguma síndrome genética de base e escalonou a investigação, realizando cariótipo, posteriormente Análise Cromossômica por array-CGP 400 K (CGH + SNP), ambos sem alterações e concluiu pela solicitação de Exoma.

Histórico de Exames:

(20/4/21):

TSH: 3,43. T4L: 1,22 (0,94-1,53). T4 Total: 9,7 (4,5-12,3).

T3T: 1,39 (0,6-1,71). Cortisol: 22,8. IGF1: 15 (18-172).

IGFBP3: 1 (0,7-3,6). ACTH: 6 (<46).

07/12/21: TSH: 2,56. GJ: 60. Fosf alc: 514 (129-376). Íons N.

T4L: 1,07. Cortisol: 26,3. IGF1: 18 (18-172). IGFBP3: 1,5 (0,7-3,6).

Acompanhamento clínico, antropometria:

6m: 4,8-58. 1a1m: 5,86-64. 1 ano 7 meses: P: 6370g. Cp: 69 cm.

1 ano 10 meses: P: 6,8 kg. Cp: 71,5 cm.

Rua Domingos Vieira. Número: 300 Salas 503-504. Bairro Santa Efigênia. CEP: 30150-240.

BH/MG (DDD: 31). Tel: 32413178 – 973032089 (Whatsapp) – 991313474. www.espacodiabetes.com.br
cristianoendocrino@gmail.com www.facebook.com/cristianoendocrinopediatra



Dr. Cristiano Túlio Maciel Albuquerque – Endocrinologista Pediátrico.

Coordenador da Endocrinologia do Hospital Infantil São Camilo.

Membro do Programa de Educação em Diabetes para Crianças e Adolescentes do Hospital das Clínicas da UFMG.

Atual: P: 7,65 kg. Cp: 75,5 cm. mantendo baixa velocidade de crescimento e estatura abaixo de 2 desvios-padrão negativos.

Diagnóstico:

Criança com uso de Válvula de Sistema Nervoso Central, Derivação Ventrículo-peritoneal. Histórico de Acidente Vascular Encefálico, com Hemorragia em SNC Grau III.

Baixa Estatura Extrema, com sinais sindrômicos. CID: E34.3.

CIUR + PIG: CID: P05.1.

Conclusão: Deficiência de GH muito provável por dano hipofisário (Hipopituitarismo) e tem restrições de peso aos testes de estímulo para secreção de GH.

Síndrome Genética sob Investigação.

Baseado no exposto, solicito realização de exame genético: Sequenciamento de Nova Geração de Todas As Regiões Codificadoras (Éxons) de Todo Os Genes do Genoma - Sequenciamento do Exoma (Inclui Captura, Amplificação e Sequenciamento) (Com Diretriz de Utilização Ans) (40503810)

O exame está incluído no Rol da ANS, mediante Diretriz de Utilização, que foram cumpridos pela paciente. Não pode ser substituído pelo Sequenciamento de Genes Isolados Específicos – NGS, por não haver uma hipótese direcionada a uma das patologias cobertas pelo exame.

A realização do exame é fundamental para evolução do caso, uma vez que poderá direcionar o tratamento adequado da baixa estatura e o plano de linha de cuidado das possíveis intercorrências durante a vida da paciente.

Atenciosamente, à disposição.



Dr. Cristiano Túlio Maciel Albuquerque. CRMMG: 38.231.

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2022.

Rua Domingos Vieira. Número: 300 Salas 503-504. Bairro Santa Efigênia. CEP: 30150-240.

BH/MG (DDD: 31). Tel: 32413178 – 973032089 (Whatsapp) – 991313474. www.espacodiabetes.com.br
cristianoendocrino@gmail.com www.facebook.com/cristianoendocrinopediatra